EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 80611
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-13 13:33:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BERNARDA ISABEL BURGOS MEDEL			RUN	: 5.330.312-9
F.Nac	: 28-02-1942	Edad	: 82 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-01	Fecha Egreso	: 2024-03-13 13:33:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K92.2-HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ICC FEVI 37 % descompensada (EcoTT 2021)
a. Derrame pleural bilateral mayor a derecha
2. Neumonía nosocomial
a. Tratamiento con tazobactam día 2
3. Hemorragia Digestiva Baja
a. Rectitis actínica
b. Anemia moderada normocítica normocrómica Hb 8.0
4. AKI KDIGO II en vías de recuperación (Crea basal 0.8)
5. Delirium
6. Hipotiroidismo
7. HTA
8. ACV hace 3 meses
9. Cáncer de mama izquierdo 2010 tratado con mastectomía QT
10. Cáncer endometrial 2018: tratado con HT + RT.
11. Usuaria de marcapasos
12. Dependiente moderada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K62.5-HEMORRAGIA DEL ANO Y DEL RECTO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 82 años con antecedentes descritos, es traída al servicio de urgencias del HSC el 29/02 por cuadro de compromiso del estado general, dolor abdominal asociado a náuseas y sin vómitos. Fiebre en domicilio no cuantificada en urgencias. Al ingreso FC 88 lpm, PA 135/75; T 36.4°C, Sat 91% ambiental HGT 106 mg/dl. Se evidencia rectorragia, por lo que es evaluada por UPC y UTI quienes indican sin criterios por dichas unidades y manejo por cirugía. Evaluada por cirugía quienes pesquisan antecedente de rectitis actínica tratada con Argon plasma el año pasado. Se solicitan exámenes donde se evidencia anemia moderada (Hb 8); plaquetas 223.000, leucocitos 7.200, INR 1.51, PCR 13.2, sin alteraciones hidroelectrolíticas. Creatinina 1.3. Además, TC de abdomen y pelvis que evidencia cardiomegalia, derrame pleural bilateral, signos de proctitis sin liquido libre. Cirugía indica que paciente no se encuentra con criterios de cirugía de urgencia actual por lo

que el manejo queda a cargo de medicina, decidiéndose hospitalización.
Paciente es trasladada a medicina el 03/01/2024, se inicia solicitud en HCHM para realizar colonoscopia con argon plasma, la cual se logra tramitar para el 28/03/24.
Durante hospitalización se evidencia clínica respiratoria, por lo que se solicita radiografía de tórax que impresiona gran cardiomegalia, y posible proceso infeccioso por lo que se solicita TC torax sin contraste para estudio de neumonía. TC torax evidencia Cardiopatía izquierda congestiva con derrame pleural bilateral mayor en el derecho y edema pulmonar intersticial. Liquido en el receso pericárdico postero superior, sin embargo se aprecia condensación adyacente a zonas de congestion pulmonar. Por lo que inicialmente se ajusta terapia para insuficiencia cardiaca con FEVI reducida. Sin embargo, paciente presenta mayor compromiso respiratorio, hasta requerir oxigeno con naricera, con aumento de parámetros inflamatorios hasta valores de PCR 80-85 de forma estacionaria, con procalcitonina negativa. Se decide iniciar tratamiento ATB empirico para neumonía nosocomial con piperacilina tazobactam, actualmente paciente en su segundo dia completo, sin requerimientos de oxigeno.
Se solicita durante hospitalización niveles de TSH por hipotiroidismo, los cuales se evidencian aumentados, por lo que se ajusta terapia con levotiroxina 100 mcg lunes a viernes- 150 mcg sábado y domingo (control en 6 semanas).
Durante hospitalización, familiares diariamente manifiestan deseo de traslado a domicilio de paciente. Se explica condición clínica e indicación médica de mantener a paciente en hospital. Sin embargo, familiares solicitan traslado a HODOM. En caso de deterioro clínico durante hospitalización domiciliaria, se decide con familiares a cargo no hospitalizar nuevamente en servicio de medicina o traslado a unidad de urgencias y realizar cuidados de fin de vida por Hodom.
Actualmente sin sangrados activos, sin necesidad de transfusiones. Sin requerimientos de oxígeno. En regulares a malas condiciones generales. Se decide traslado a HODOM por deseo de familiares debido a multiples patologías crónicas de mal pronostico y el deseo de paciente de pasar últimos días en su domicilio.

PLAN DE MANEJO:

Cardiaco: ICC con FEVI disminuida, mantener BB, espironolactona, empaglifozina, entresto a 1 compr cada 12 h y dosis de metolazona a 2-1 comprimidos día.
Respiratorio: Con TC de tórax sin contraste que evidencia, cardiopatía izquierda congestiva con derrame pleural bilateral mayor en el derecho y edema pulmonar intersticial. Actualmente impresiona componente mixto (cardiaco/infeccioso). Continuar KNT, broncodilatadores. actualmente más de 48 horas sin oxígeno.
Infeccioso: En tratamiento por neumonía nosocomial, impresiona imagen en condensación en TC (no informado), Tazonam segundo dia. CSB negativo. Por traslado a HODOM se indica ajuste de tratamiento empirico a Ertapenem 1g dia + ciprofloxacino 500 mg cada 12 h VO por 5 dias.
Digestivo: Hora HCHM 28/03 para argón plasma. Sin sangrados activos actuales, vigilar. Anemia moderada estable Hb 8.
Endocrino: Actual TSH 12.697; ajuste de Levotiroxina 100 mcg L-V; S-D 150 mcg (ajuste el 08/03, aumento 14% semanal)
Proporcionalidad terapéutica: no RCP, no IOT, de responder mal a tratamiento iniciar cuidados de fin de vida (conversado con familia)

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Traslado a HODOM
2. 2. Reposo relativo asistido
3. 3. Régimen liviano hiposódico
4. 4. Prevención de LPP, uso de colchón antiescaras
5. 5. CSV c 6hrs + HGT SOS
6. 6. Oxígeno para Sat > 93%
7. 7. KNT respiratoria y motora
8. 8. Levotiroxina 100 mcg L-V; S-D 150 mcg
9. 9. Ertapenem EV 1 vez al dia por 5 dias
10. 10. Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h VO por 5 dias
11. 11. Empaglifozina 10 mg cada dia VO
12. 12. Metolazona 2.5 mg: 2 comprimidos am- 1 comprimido pm
13. 13. Valsartan/Sacubitril 50 mg 1 comprimido cada 12 h
14. 14. Quetiapina 25 mg cada noche VO
15. 15. Bromuro de ipatropio 4 puff cada 8 h por AEC
16. 16. Carvedilol 6.25 mg ½ comprimidos cada 12 h VO
17. 17. Ferranim 1 capsula cada 48 h por VO

18. 18. Espironolactona 25 mg cada dia VO
19. 19. Colonoscopia en HCHM con Argon Plasma marzo 28

EXÁMENES Y RESULTADOS

Lab 12/03
- Albumina 2.8, crea 1.1, Calcio 8.1, fosforo 3.4, pcr 89.6, BUN 45, ELP 147, K 3.5, Cl 112, TFG 47.55
- Hb 8.0, Hcto 25.8, Leucocitos 12.500, Plaquetas 186.000, segmentados 83%
- CSB negativo

Lab 08/03
- Albumina 3.0, PCR 82.2
- Crea 1.3, Calcio 7.6, TFG 39.21 BUN 69, calcio corregido 8.4
- Leucocitos 11.200, Hcto 23.5; Hb 7.6; VCM 78.8, CHCM 32.3, Plaquetas 162.000, VHS 19
- TSH 12.697
- GSA: ph 7.44, pCO2 26.2, pO2 68.7, HCO3 17.9, SatO2 92%; FiO2 32% Pafi 215C Ca iónico 0.4
- Lab 07/03
- Glicemia 115, Crea 1.5, TFG 33.25, Calcio 7.8, Fosforo 4.3, LDH 405 lactato 1.4 PCR 85.6 Na 147, K 3.2, Cl 113
- Hb 7.8, Hcto 24.2, plaquetas 180.000, leucocitos 12.100, INR 1.56, TP 20.4
- GSV: PH 7.43, pco2 26.3, hco3 17.6, SatO2 91%
- Albumina 3.1

TC tórax 07/03: Cardiopatía izquierda congestiva con derrame pleural bilateral mayor en el derecho y edema pulmonar intersticial. Liquido en el receso pericárdico postero superior.

OBSERVACIONES:

Interna Maria Jose Cartes
Dr. Jorge Villa Flores

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO